A.O. Monte Lauro
Presidio Ospedaliero Gaetano Fichera
UOC Anatomia Patologica e Patologia Molecolare
Direttore: Dott.ssa Giovanna D'Urso

Via Santa Sofia 210
95123 Catania
Tel. 095 7436612
ap.fichera@aomontelauro.example.it

REFERTO ISTOPATOLOGICO E BIOMOLECOLARE

Lobectomia superiore destra VATS con linfadenectomia ilo-mediastinica sistematica

PAZIENTE

Cognome:	**NGUYEN**
Nome:	**THANH**
Nato a:	**Lione (Francia)**
Il:	**22/04/1961**
Cittadinanza:	**francese**
Residenza:	**Via Garibaldi 288, 95121 Catania**
Professione:	**saldatore navale (in pensione)**

N. istologico:	2025-CT-07719
Ricovero:	RIC-25-118402
Intervento:	10/02/2025
Pervenuto:	10.02.25
Referto:	24/02/2025
Chirurgo:	Dott. Salvatore Privitera
Pneumologo:	Dott.ssa Agata Russo Spampinato

Codice fiscale N G Y T N H 6 1 D 2 2 Z 1 1 0 X

Tessera sanitaria 8 0 3 8 0 1 6 0 1 9 6 1 3 0 5 4 0 5 9 5

NOTIZIE CLINICHE

Uomo di 63 aa., tabagismo attivo (40 pack-years), ex saldatore presso Cantieri Navali Ionici S.p.A. dal 1982 al 2016 con riferita esposizione ad amianto; invalidità civile al 75%; disturbo d'ansia generalizzato in terapia con escitalopram 10 mg; BPCO GOLD 2. TC torace: nodulo solido spiculato di 34 mm del lobo superiore destro con retrazione pleurica; PET: SUVmax 9,6. Broncoscopia con EBUS-TBNA preoperatoria (rif. 2025-CT-01408) negativa sulle stazioni 4R e 7. Il paziente, che parla italiano e francese, è stato accompagnato dalla moglie, sig.ra Speranza Lo Iacono (+39 392 115 4870), e dal figlio Luca Nguyen.

ESAME ESTEMPORANEO INTRAOPERATORIO

Rif. EST-25-0388 del 10/02/2025, ore 10:42. Materiale: resezione atipica (wedge) del lobo superiore destro. Risposta comunicata in sala al Dott. Privitera alle 11:05 dal Dott. Orazio Licciardello: **"carcinoma non a piccole cellule, verosimilmente adenocarcinoma; margine parenchimale indenne"**. Esito confermato in definitiva.

MATERIALE INVIATO

Cont.	Descrizione	Blocchetti	Note del prelevatore
A	Wedge LSD (estemporaneo)	A1-A2	Congelato, poi fissato
B	Lobo superiore destro	B1-B14	Punto di repere sulla pleura retratta (firma inf. Rosario Finocchiaro, sala 3)
C	Stazione 2R	C1	-
D	Stazione 4R	D1-D2	-
E	Stazione 7 (sottocarenale)	E1-E2	-
F	Stazioni 10R-11R (ilari e interlobari)	F1-F3	Linfonodi antracotici
G	Stazione 8-9 (paraesofagea e legamento polmonare)	G1	-

DESCRIZIONE MACROSCOPICA

(A cura della Dott.ssa Chiara Mangano, medico in formazione specialistica, e della TSLB Rosa Pappalardo.) B) Lobo polmonare di cm 16 x 11 x 5, peso g 238, con bronco lobare di cm 1,5 alla trancia. Superficie pleurica con area retratta e ombelicata di cm 1,8 in corrispondenza del segmento apicale. Al taglio neoformazione solida, grigio-biancastra con aree antracotiche, di cm 3,6 x 3,1 x 2,8, a margini infiltrativi, che giunge a contatto con la pleura viscerale, distante cm 2,9 dalla trancia bronchiale e cm 2,2 dal margine vascolare. Parenchima circostante enfisematoso; placca fibroialina pleurica parietale (pervenuta adesa) di cm 1,2.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Adenocarcinoma invasivo non mucinoso con pattern acinare prevalente (55%), papillare (15%), micropapillare (20%) e lepidico (10%); dimensione della componente invasiva 3,3 cm. Grado IASLC G3 (pattern di alto grado >= 20%). Alla colorazione Elastica van Gieson si documenta superamento della lamina elastica pleurica senza esposizione in superficie (PL1). Diffusione aerogena (STAS) presente. Invasione vascolare presente, linfatica assente, perineurale assente. Nel parenchima circostante iperplasia delle cellule di Clara (club cells) dei bronchioli terminali, enfisema centrolobulare e fibrosi interstiziale lieve; alla colorazione di Perls rari corpuscoli dell'asbesto (3 corpuscoli/cm²). Le cellule di Kulchitsky dei bronchi sono regolari, senza iperplasia neuroendocrina (DIPNECH esclusa).

Linfonodi esaminati per stazione (IASLC)

Stazione	Esaminati	Metastatici	Note
2R paratracheale alta	3	0	-
4R paratracheale bassa	4	0	Antracosi
7 sottocarenale	3	0	-
10R-11R ilari/interlobari	5	0	Linfonodo intrapolmonare indenne
8-9	2	0	-
Totale	17	0/17	pN0

INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI

Marcatore / gene	Metodica	Risultato	Note
TTF-1 (8G7G3/1)	IIC	positivo diffuso	Origine polmonare
Napsina A	IIC	positiva	-
p40	IIC	negativo	Esclusa componente squamosa
PD-L1 (22C3)	IIC	TPS 30%	Espressione intermedia (1-49%)
ALK (D5F3)	IIC	negativo	-
ROS1 (D4D6)	IIC	negativo	-
EGFR	NGS (pannello DNA/RNA 52 geni)	delezione esone 19 p.E746_A750del	VAF 27%; mutazione sensibilizzante
TP53	NGS	variante TP53 p.R273H	Co-mutazione
KRAS, BRAF, MET, RET, NTRK	NGS	nessuna alterazione	-

Analisi biomolecolari eseguite su DNA estratto dal blocchetto B6 (cellularità neoplastica 60%), campione NGS-25-0217, dal Dott. Emanuele Pappalardo, Laboratorio di Patologia Molecolare.

DIAGNOSI

Lobo superiore destro: adenocarcinoma polmonare invasivo non mucinoso a prevalenza acinare, grado 3 IASLC, di cm 3,3 (componente invasiva), con invasione della pleura viscerale (PL1), STAS e invasione vascolare. Margini bronchiale, vascolare e parenchimale indenni (R0).
Linfonodi: 0/17. Stadio pT2a pN0 (8a ed. TNM), stadio IB.
EGFR mutato (delezione esone 19); PD-L1 TPS 30%; ALK e ROS1 negativi.
Reperti associati: enfisema centrolobulare, placca pleurica fibroialina e corpuscoli dell'asbesto, quadro compatibile con pregressa esposizione professionale ad amianto.

(1) Lo stadio è attribuito sulla base della dimensione della sola componente invasiva, come previsto dalla classificazione WHO 2021.
(2) La presenza di placche pleuriche e corpuscoli dell'asbesto in un ex lavoratore dei Cantieri Navali Ionici comporta l'obbligo di denuncia di malattia professionale (art. 139 DPR 1124/1965): segnalazione inoltrata all'INAIL dalla Dott.ssa D'Urso con prot. INAIL-CT-2025-004417 in data 26/02/2025.
(3) La moglie del pz., sig.ra Lo Iacono, ha richiesto una copia del referto: consegnabile solo con delega firmata dal sig. T. Nguyen e documento d'identità.

Catania, 24 febbraio 2025

Il Dirigente Medico refertante
Dott.ssa Giovanna D'Urso

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

SCHEDA DI TRASMISSIONE AL GOM TORACICO

Discussione del 5 marzo 2025 - richiesta di terapia adiuvante a bersaglio molecolare

Ruolo	Nominativo	Recapito
Oncologo di riferimento	Dott. Bao Tran Moretti	UOC Oncologia Medica, int. 095 7436288
Chirurgo toracico	Dott. Salvatore Privitera	UOC Chirurgia Toracica
Pneumologa	Dott.ssa A. Russo Spampinato	Ambulatorio di Pneumologia Interventistica
Medico curante	Dott. Carmelo Sciacca	Via Etnea 402, Catania - 095 441208
Caregiver	Speranza Lo Iacono (moglie)	+39 392 115 4870
Patronato	Patronato Sicilia Lavoro (pratica INAIL)	pratica n. PSL/25/0912

Il paziente sig. Nguyen ha dato consenso a:

- ☒ discussione del caso al GOM
- ☒ comunicazione dell'esito al figlio Luca
- ☒ uso del tessuto per ricerca (biobanca)
- ☐ contatto da parte del patronato

Proposta: in considerazione dello stadio IB con delezione dell'esone 19 di EGFR, valutare terapia adiuvante con osimertinib per 3 anni, previa valutazione cardiologica. Il paziente segue già un percorso di disassuefazione dal fumo presso il Centro Antifumo (dott.ssa Valeria Ingrassia, psicologa).

Fascicolo GOM di NGUYEN THANH - accesso riservato:
https://gom.aomontelauro.example.it/caso/GOMT-25-0071